Diskussion 2193

Datum: 1939-05-30
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 4
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Otto Holmdahl (Högerns riksdagsgrupp, man)

Herr förste vice talman! Vid detta utskottsutlåtande är fogad en blank reservation av mig, men innan jag går in på innebörden av denna reservation, skall jag tillåta mig att beröra en punkt i utlåtandet, som icke avses med reservationen.

Som **damerna²** och herrarna torde finna, har utskottet med anledning av motionsvis framförda yrkanden under punkten B i utlåtandet föreslagit, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning rörande lämpligheten och möjligheten av att genomföra evalvering av vissa läkare vid de statliga sjukhusen tillkommande ersättningar av patienter å enskilda och halvenskilda rum. Det är om denna punkt i utskottets utlåtande som Jag först skulle vilja säga ett par ord. Jag är nämligen av den meningen, att det knappast är lämpligt att vid dessa stora statssjukhus i Stockholm genomföra en dylik evalvering. Jag skall icke gå närmare in på denna mycket omfattande och vittutseende fråga, utan jag skall endast tillåta mig att göra den reflexionen, att det nog kan vara sant, som motionärerna framhållit och som också framhållits under utskottsbehandlingen, att man inom vissa landstingsområden på ett lyckligt sätt genomfört en sådan evalvering, då det gällt chefsläkarens löneförhållanden, men jag kan icke underlåta att fästa uppmärksamheten vid att svårigheterna bli mycket större, då det gäller dessa stora centrala, i landets huvudstad belägna sjukhus, vilkas chefsläkare samtidigt äro professorer vid karolinska institutet, vilka ha att ombesörja en mycket viktig del av utbildningen utav landets blivande läkare. Det synes mig uppenbart, att det är av utomordentlig betydelse, att man icke vidtar sådana anordningar beträffande lönerna för dessa chefsläkare, att man därigenom äventyrar möjligheterna att få de mest kvalificerade krafterna på ifrågavarande poster. Därtill kommer ännu en omständighet, nämligen att man här i Stockholm måste taga hänsyn till de förhållanden, som råda vid Stockholms stads stora kommunala sjukhus. Att jag emellertid icke reserverat mig på denna punkt beror därpå, att utskottet i denna fråga skrivit synnerligen försiktigt och att utskottet också framhävt de svårigheter, som jag nu påpekat, ävensom att utskottet direkt utsäger, att man önskar, att utredningen skall göras förutsättningslös under

Jag skall sedan endast med några ord beröra den blanka reservation, jag här avgivit. Den avser en detalj i Kungl. Maj:ts nu förevarande proposition, och denna detalj omnämnes i det första stycket på sid. 50 i utskottets utlåtande. Där behandlas frågan om rätt för underläkarna till ersättning för vissa intyg rörande arbetsoförmåga och invaliditet. Utskottet ansluter sig på denna punkt till vad Kungl. Maj:t föreslagit eller att redan vid denna riksdag beslut må fattas

om en väsentlig begränsning av vissa läkares rätt till dylik ersättning i enlighet med ett av statskontoret framlagt förslag. Den nya ordningen, som skulle vara ett provisorium, skulle innebära, att sjukhusen skulle erhålla hälften av ersättningen för ifrågavarande intyg, medan läkarna skulle få behålla den återstående hälften. Av propositionen att döma synes emellertid departementschefen ha varit tveksam, huruvida frågan om dessa erszättningar nu borde upptagas till behandling. Han uttalar i propositionen, att skäl kunna anföras för att hänskjuta hela frågan till de nu arbetande s. k. 1938 års hälsooch sjukvårdssakkunniga. Departementschefen tillägger emellertid, att han med hänsyn till ett uttalande i saken av fjolårets riksdag anser sig böra föreslå, att riksdagen redan nu fattar ett positivt beslut. Det förhåller sig också så, att fjolårets riksdag i skrivelse till Kungl. Maj:t uttalade sig för ett borttagande av denna vissa läkare tillkommande ersättning för invaliditetsintyg. I skrivelsen uttalade riksdagen emellertid också, att frågan om avskaffandet av ersättning för dylika intyg borde göras till föremål för en fortsatt utredning, vilken borde avse jämväl ersättning för likartade intyg inom övriga socialförsäkringsgrenar. Min blanka reservation, herr förste vice talman, innebär nu, att jag anser, att ersättningsfrågan, som berör läkarna vid de här ifrågavarande statliga sjukhusen, icke nu borde lösas fristående utan först efter en mera omfattande och allsidig utredning, något som riksdagen också uttalat sig för. Sakkunniga myndigheter, som hörts i ärendet, t. ex. karolinska institutets direktion, medicinalstyrelsen, riksförsäkringsanstalten och De ömsesidiga försäkringsbolagens förening, ha uttalat sig mot en förändring. Dessa myndigheter ha i sina yttranden framhållit, att det funnits en gammal, för hela riket giltig hävd rörande ersättning för läkarintyg och att starka betänkligheter måste resas mot att placera serafimerlasarettets och det nya Karolinska sjukhusets läkare i en sämre ställning beträffande detta ersättningssystem. Jag har icke kunnat finna det motiverat, att, innan hela denna fråga blivit grundligt, allsidigt och även från principiella synpunkter utredd, vidta särskilda åtgärder till nackdel för de yngre läkarkrafterna vid statens sjukhus i Stockholm.

Med anledning av vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till motionen nr 434 i denna kammare, som företräder den ståndpunkt jag här skisserat.

2. Kerstin Hesselgren (Folkpartiet, woman)

Jag har i anledning av Kungl. Maj:ts förevarande proposition väckt en motion, i vilken jag hemställt, att vid Karolinska sjukhuset måtte inrättas en ordinarie social kuratorstjänst i lönegrad A 11. Motionen har enhälligt avstyrkts av utskottet, och jag förstår, att det inte är någon som helst mening 1 att yrka bifall till motionen. Jag har emellertid begärt

Ång. anslag till karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet m. m. (Forts.) ordet för att få tillfälle att understryka, att utskottet i varje fall icke tycks ha tagit definitiv ställning till den fråga, motionen avser. Utskottet talar visserligen om att det är en oprövad sak, som jag här föreslår, att t. ex. Lunds psykiatriska klinik icke har någon social kurator och att man därför icke kan vara säker på att man behöver en sådan kurator vid Karolinska sjukhuset, men det oaktat har jag den känslan, att utskottet icke anser det uteslutet, att den socila kuratorsverksamheten blir bättre ordnad i framtiden. Jag tror, att det är utomordentligt viktigt,

att man har möjlighet att vid Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik fästa en fullt utbildad god kraft, som skall göra de sociala utredningar, vilka absolut behövas inom sinnessjukvården. Den moderna sinnessjukvårdens målsmän förstå betydelsen av att ta reda på de sociala förhållanden, under vilka patienten lever eller kommer att leva. För detta sjukhus, som kommer att ta emot folk från hela landet och som är en utbildningsanstalt för blivande läkare, är det naturligtvis av särskild vikt, att de sociala undersökningar, som företagas, utföras av väl kvalificerade personer. Utskottet har i denna fråga anslutit sig till Kungl. Maj:ts förslag, att man för ifrågavarande uppgifter vid Karolinska sjukhuset skulle anlita en vid Psykiatriska sjukhuset redan verksam extra ordinarie befattningshavare i 7:e lönegraden, d. v. s. en person, som icke åtnjuter ens föreståndarinnelön. Förut har den sociala kuratorsverksamheten vid Psykiatriska sjukhuset ombesörjts av befattningshavare i nämnda lönegrad. Följden härav har blivit, att Stockholms stad lockat bort flere sådana befattningshavare, när de blivit färdiga för sin uppgift, och sedan placerat dem i 15:e lönegraden enligt stadens löneskala. Jag tror därför, att det är olyckligt, om man låter den sociala kuratorsverksamheten handhavas av befattningshavare i sådan löneställning att man ej kan fordra någon extra utbildning utöver en vanlig **sjuksköterskas**[3]. Jag har emellertid den förhoppningen, att de förhållanden, jag nu berört, skola rättas till så småningom. Utskottet säger, att det inte nu vill göra någonting, och Kungl. Maj:t säger, att Kungl. Maj:t för närvarande inte vill göra någonting. I detta »nu» och detta »för närvarande» inlägger jag ett löfte om att man längre fram skall söka få till stånd en bättre anordning.

Herr förste vice talman, jag har inte något yrkande.

3. Edvin Leffler (–, man)

Jag skulle ha kunnat begränsa mig till att instämma 1 herr Holmdabhls anförande, ty de synpunkter han framlade överensstämma helt med mina egna. Som motionär tillåter jag mig emellertid att några ögonblick ta kammarens uppmärksamhet i anspråk. Den fråga vi nu behandla har varit föremål för de två närmast föregående riksdagarnas prövning. Man får — såsom herr Holmdahl påpekat — det intrycket, att departementschefen varit tveksam, huruvida han nu borde framlägga ett förslag om begränsning av vissa läkares rätt till intygsersättning. Departementschefen har emellertid ansett, att frågan om en sådan begränsning redan nu borde bli föremål för riksdagens beslut, och till stöd härför åberopar han en, mina herrar, jag påpekar det, en reservant inom Jlasarettsdirektionen, statskontorets yttrande och riksdagens uttalande förra året. Om man granskar 1938 års riksdagsprotokoll, skall man emellertid finna, att det fanns en mycket stark opposition mot det förslag, som då framlades i denna fråga. Särskilt statsutskottets ärade ordförande gick mycket kraftigt emot förslaget och yrkade, att detsamma skulle bli föremål för en allsidig utredning. Detta yrkande åtföjdes av ett tjugutal instämmanden från olika partier inom kammaren. Det betyder dock en hel del, att en så kraftig opposition reses mot ett förslag av här ifrågavarande art.

4. Conrad Jonsson (Socialdemokraterna, man)

Vad beträffar den av herr Holmdahl först berörda frågan, om den s. k. evalveringen, erkände herr Holmdahl själv, att utskottet skrivit synnerligen försiktigt härom, även om utskottet röjt

sin sympati för den tanke, som ligger under motionerna. Det kan därför vara onödigt att jag vidare uppehåller mig vid denna del av herr Holmdahls anförande.

Vad sedan frågan om intygsersättningarna angår, vill jag erinra därom, att lasarettsnämnden bestämt påyrkat dessa ersättningars avskaffande, att riksdagen 1937 ställde sig på lasarettsnämndens ståndpunkt, att riksdagen i fjol underströk vad riksdagen tidigare i saken uttalat samt att statskontoret i allt väsentligt haft samma mening som lasarettsnämnden och preciserat ett förslag, på vilket departementschefen baserat propositionen i nu förevarande del.

Vidare vill jag erinra om en sak, när herr Leffler åberopar 1938 års sjukvårdssakkunniga, nämligen att dessa ha ställt sig på statskontorets stånd-

Ang. anslag till karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet m. m. (Forts.) punkt i saken. Det är således två riksdagar och en rad av institutioner, som ha uttalat sig för att intygsersättningen, som det nu är fråga om, skulle avskaffas. Jag fäster vidare uppmärksamheten på att de nu anställda läkarna, som få nytta av dessa ersättningar, fortfarande skulle få 90 procent av avgifterna, och att lasaretten skulle ta de tio procenten, samt att därefter i den mån förordnandena utgå och nya läkare förordnas, de skulle få hälften av avgifterna medan den andra hälften skulle gå till lasaretten. Jag erinrar vidare om att det här inte rör sig om något annat än om ett provisorium i avvaktan på en utredning, som väl enligt vad vi allesammans eller åtminstone de flesta hoppas, skall definitivt avskaffa intygsersättningarna till läkarna.

Statsutskottet riktar sig lika litet som departementschefen emot läkarna. De kunna möjligen behöva en kompensation. Om jag inte missminner mig, har jag vid en föregående debatt i detta ärende uttalat mig därför. Det är sålunda inte fråga om att man skall ta ifrån läkarna något, som de kunna behöva ha, utan det är fråga om att på annan väg ge dem någon ersättning för dessa arvoden, och under alla förhållanden är det fråga om en jämnare fördelning av dessa inkomster mellan läkarna. Direktionen för serafimerlasarettet erkänner själv i sitt uttalande, att det inte är bra som det är och att det borde vara en jämnare fördelning.

Vad **fröken²** Hesselgrens intresse för den sociala kuratorn beträffar, så kan jag ju bekänna, att jag står ganska nära **hennes²** uppfattning i saken. Men man vet inte ännu, huruvida vid ett sinnessjukhus och i vart fall vid den sinnessjukvård, som det här är fråga om, behövs en social kurator med den utbildning, som man har på andra ställen och som anses böra avlönas enligt elfte lönegraden. Den saken får undersökas. Erfarenheten från psykiatriska kliniken, när den flyttas över till Karolinska sjukhuset, får visa, i vad mån man inte kan nöja sig med en social kurator av det slag, som man nu har, utan måste ha en med större lön och följaktligen, så vitt jag förstår, också med större kompetens.

Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.